

SH.GSR.04.ACT.08			رقم السياسة
التسليم والتسلم			عنوان السياسة
٢	رقم الإصدار	٢٠٢٦/٠٣/٠١	تاريخ إعداد
٢٠٢٦/٠٤/٠١	تاريخ اعتماد	٢٠٢٦/٠٤/٠١	تاريخ تفعيل
٩	عدد الصفحات	٢٠٢٩/٠٤/٠١	تاريخ المراجعة
جميع الأقسام الاكلينيكية ب المستشفى			نطاق التفعيل
اعتماد	مراجعة		إعداد
مدير المستشفى د/ وسام وهيبه	لجنة الجودة د/ ايمان سامي		مدير الشؤون العلاجية د/ محمد مختار رئيسة التمريض م/ هيام محمود فريق الجودة د/ باسل محمد - م/ ولاء سيد



د/ ايمان سامي السيد
 مديرة الجودة
 مستشفى سيدناوى

- يلتزم الفريق الطبي (أطباء وتمريض) بالمستشفى بعملية التسليم والتسلم لأحوال المرضى بالأقسام المختلفة ومن قسم لآخر وتشمل:

○ تحديد المسئول عن التسليم والتسلم.

○ تحديد الواجبات الضرورية الواجب تداولها أثناء عملية التسليم والتسلم حسب نموذج ISBAR

○ تسجيل عملية التسليم والتسلم (من قسم إلى قسم آخر).

الغرض

- تهدف هذه السياسة إلى ضمان فاعلية نقل المعلومات الإكلينيكية بصورة دقيقة عند نقل مسؤولية المرضى لضمان استمرارية الرعاية الصحية وسلامة وأمان المريض وتقليل المخاطر الإكلينيكية التي قد يتعرض لها المريض.

التعريفات

التسليم والتسلم:

- هي عملية الهدف منها هو التأكد من وجود نظام فعال يضمن طريقة سليمة لتسليم وتسلم أحوال المرضى.
- هو نقل المسؤولية عن المريض ورعايته التي تحدث في مكان تقديم الرعاية الصحية على سبيل المثال
- في المستشفى من متخصص رعاية صحية إلى آخر ومن مستوى رعاية الي مستوى اخر
- من وحدة تشخيص المرضى المحجوزين بالمستشفى الى وحدة تشخيصية أخرى ومن العاملين بالمستشفى الي المرضى والأسر عند الخروج من المستشفى

إجراءات العمل

(١) يتم استخدام نموذج ISBAR في التسليم و التسلم داخل المستشفى وعناصره كالآتي

- I- Identification: تعريف المريض بطريقة صحيحة
- S- Situation : الموقف الحالي للمريض
- B- Background: التاريخ المرضى للمريض
- A- Assessment: تقييم المريض
- R- Recommendation : التوصيات

(٢) تتم عملية التسليم و التسلم في الحالات التالية :

- بين الأطباء من نفس التخصص مع تغيير النوبتجيات عن طريق استخدام (نموذج ملاحظات التقدم الإكلينيكي للأطباء).

- بين الأطباء من تخصصين مختلفين بقسمين مختلفين عند إحالة المريض من قسم إلى آخر عن طريق استخدام

(Internal Referral Form).

- بين أعضاء التمريض يتم التوثيق في (نموذج التسليم والتسلم ISBAR) في الحالات الآتية:

- مع كل تغيير نوبتجية (نموذج ملاحظات التمريض).

- عند التحويل من قسم إلى آخر (نموذج تحويل داخلي)

- أعضاء التمريض عند نقل المريض من القسم إلى العمليات (نموذج الجراحة الآمنة sign in).

- أعضاء التمريض عند نقل المريض من غرفة العمليات إلى الإفاقة (نموذج القائمة التفقدية)

- أعضاء التمريض عند نقل المريض من الإفاقة إلى القسم الداخلي (نموذج عناية الإفاقة).

- بين أعضاء المستشفيات عند نقل المريض خارج المستشفى لعمل إجراء طبي (نموذج إحالة)

- بين أعضاء المستشفيات عند نقل المريض خارج المستشفى وبعد عودته مرة أخرى (نموذج تحويل خارجي)

(٣) يلزم تواجد الطرفين أثناء التسليم و التسلم لضمان التفاعل وإتاحة الفرصة لطرح الأسئلة وتوضيح أي لبس

(٤) على كل طرف من اطراف التسليم و التسلم تحديد المسؤوليات الأساسية لكل منهما و توفير المعلومات الكاملة و و

التحقق من استيعاب الخطة العلاجية

(٥) يتم التسليم و التسلم في مكان هادئ و لا يوجد به ضوضاء، كما يجب الالتزام بحماية خصوصية المريض و عدم

السماح بتواجد أي فرد غير مصرح له بمعرفة حالة المريض او أي معلومات عنه

(٦) التوثيق:

○ الاشراف

● تقوم الممرضة المسؤولة عن المريض بتسجيل أحوال المريض طوال الشفت في نموذج ملاحظات التمريض.

● بعد انتهاء الشفت وحضور ممرضة الشفت التالي تقوم ممرضة النوبتجية السابقة والنوبتجية الجديدة بالتحضير

لعملية التسليم والتسلم للمريض كالاتي:

■ تحضير ملف المريض.

■ تبدأ عملية التسليم والتسلم على رأس المريض بتبادل المعلومات حسب عناصر نموذج

ISBAR

○ تسليم المرضى من وإلى العمليات

- تقوم ممرضة القسم الداخلي أو الرعاية بتحضير المريضة للعملية حسب تعليمات الطبيب ووفقا لكشف تحضير المريض للعمليات ويتم توثيق تحضير المريض في كشف تحضير المريض للعمليات بالملف الطبي.
- وتقوم ممرضة القسم الداخلي أو الرعاية بتسليم المريض والملف الطبي الخاص به والعلاج الخاص به (في حالة طلبه من الطبيب) إلى ممرضة العمليات في منطقة استلام المريض بقسم العمليات طبقا لنموذج تحضير مريض للعمليات وجزء استلام المريض بنموذج الجراحة الآمنة

sign in

- تقوم ممرضة العمليات بعد انتهاء العملية بتسليم المريض إلى ممرضة الإفاقة وتسجيل وقت دخول المريض إلى غرفة الإفاقة بالملف الطبي للمريض ودفتر غرفة الإفاقة.
- تقوم ممرضة الإفاقة بالاتصال بممرضة القسم المحدد نقل المريض إليه للحضور لاستلام المريض والملف الخاص به.
- تقوم ممرضة الإفاقة بتعريف المريض مع ممرضة القسم الداخلي ثم تسليم جميع المعلومات الخاصة بالمريض مثل:
- العلامات الحيوية
- وأي أدوية مطلوب تناولها.
- وأي تعليمات الطبيب.
- وأي مضاعفات تعرض لها المريض.
- وأي أخطار من الممكن أن يتعرض لها المريض مع التأكد من أمر طبيب التخدير على خروج المريض من غرفة الإفاقة.

○ ما يخص الأطباء

- تتم عملية التسليم والتسلم بين الأطباء (عند تغيير النوبتجيات).
- يقوم الأطباء المناوبين بتوثيق عملية التسليم والتسلم لأحوال المريض نموذج ملاحظات التقدم الإكلينيكي (ISBAR) الذي يشمل: (اسم المريض رقم الملف، التشخيص، التاريخ المرضي السابق، الشكوى الجديدة نتائج الفحص الطبي الإيجابية، نتائج الفحوصات التشخيصية الإيجابية خطة الرعاية).
- يقوم رؤساء الأقسام بمتابعة التسليم والتسلم بين الأطباء.

المسؤول عن التنفيذ

- التمريض.
- الأطباء.
- مشرفة التمريض بالقسم لمتابعة التسليم والتسلم بين أفراد هيئة التمريض.
- رؤساء الأقسام لمتابعة التسليم والتسلم بين الأطباء

المراقبة والتقييم

- تقوم المستشفى بتتبع وجمع وتحليل وعمل تقرير عن البيانات المتعلقة بعملية التسليم والتسلم
- KPI: يتم عمل كارت لمؤشر له علاقة بعملية مرتبطة بالسياسة مع متابعة تحقيق الهدف المراد و نسبته الناتجة من قيمة المؤشر عند القياس لضمان التحسين المستمر
- تعمل المستشفى على فرص التحسين المحددة في عملية التسليم والتسلم.

النماذج / مرفقات

- نموذج ملاحظات التقدم الإكلينيكي للطبيب.
- نموذج ملاحظات التمريض.

Internal Referral Form •

- نموذج تحويل داخلي.
- نموذج القائمة النفقية للجراحة الآمنة sign in
- نموذج عناية الإفاقة.

معايير ذات صلة

ICD.01 Uniform care, ACT.14 Patient's referral, transfer, temporary discharge, and discharge, ICD.16 Clinical practice guidelines adaptation and adoption, ICD.19 Critical results, ICD.15 Plan of Care.

المراجع

- دليل معايير اعتماد المستشفيات - الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، إصدار ٢٠٢٥. (معييار ACT.08).



الهيئة العامة للتأمين الصحي
فرع:
المستشفى :

Physician Progress Notes ملاحظات التقدم الإكلينيكي للطبيب

MR.Inp.Dr 1-1



.....: أسم المريض

الهيئة العامة للتأمين الصحي

رقم الملف الطبي للمريض:

فرع:

القسم المعالج :

المستشفى:

ملاحظات التمرّيز

						التاريخ :...../...../.....	
						التشخيص :..... القسم:..... الطبيب المعالج :.....	
		الملاحظات				الوقت	
التوقيع		Situation الوضع الحالي للمريض					
	O واعى ودخل حيز الخطورة لفقدان الوعى	O غير واعى		O واعى			
		O نعم		O لا		الوصلات	
Background ما تم خلال الشيفت							
Assessment تقييم المريض يتم الرجوع لنموذج اعادة التقييم التمريضى اليومي							
Recommendation توصيات الشيفت القادم							
توقيع التمريض المسلم :.....				توقيع التمريض المستلم :.....			
التاريخ :...../...../..... الوقت:.....							
MR.NR.1-1							



اسم المريض :
رقم الملف الطبي للمريض :
القسم المعالج :

الهيئة العامة للتأمين الصحي
فرع :
المستشفى :

Post Anesthesia Care Unit (Nursing Record) (PACU)

عناية الإفاقة

وقت دخول الإفاقة:..... Time:..... التاريخ: / / Date:

مدة العملية:..... Duration of Surgery:..... العملية:..... Operation:
Anesthesiologist:..... طبيب التخدير:..... Surgeon:..... الطبيب الجراح:
Anesthesia التخدير : ☐ General. ☐ Epidural ☐ Spinal ☐ Others

ممر هوائي O.P Airway ☐ لا يوجد أنبوب ☐ Extubated ☐ أنبوب ETT ☐ المسلك الهوائي Airway

Level of Consciousness :
أفوق ☐ Awake :
منوم ☐ Sedated :
ذهول ☐ Stuporous :
غيبوبة ☐ Comatosed :
دوخة ☐ Drowsy

Iv Line الكاثيولا

1

2

3

قسطرة فولي: Foley's Catheter ☐ أنبوبية صدرية Chest Tube ☐ بورتوفاك ☐ Port Vac ☐ رايال NGT ☐ Drains

Recovery Score : درجة الإفاقة :.....

	Time الوقت	Pre-Op Data ما قبل العملية	During Recovery أثناء الإفاقة				Remarks
الضغط BP							
النبض Pulse Rate							
التنفس Respiratory Rate							
درجة الحرارة Temperature							
FI O2							
Sa O2							

Oxygen Therapy علاج : ☐ T.Piece ☐ Nasal Can. ☐ Vent. Mask ☐ I/M:.....

Given Medication الأدوية المعطاة				
Drugs الدواء	Dose الجرعة	Route طريقة العطاء	Time الوقت	Signature التوقيع
(1)				
(2)				
(3)				
(1).....(2).....				
.....				

Urine Output كمية البول : O.....ml O Drain.....ml O Otherml

Transfer Order أوامر التحويل : O Awake أفوق O Stable مستقر O Pain Free بدون ألم

Leave to يمكن الذهاب الى : O Ward الداخلي O ICU الرعاية O CCU رعاية القلب O Others أخرى

Instruction التعليمات:.....

Time of Transfer وقت الخروج :.....

Anesthetist Signature توقيع طبيب التخدير :..... PACU Nurse:..... ممرضة الإفاقة NB* Medication

to be given post PACU should be written in medication once sheet.

MR. An. 1-1



اسم المريض :
 رقم الملف الطبي للمريض:
 القسم المعالج :

الهيئة العامة الصحي
 فرع:
 المستشفى

القائمة التفقدية للجراحة الامنة

التشخيص :
 مكان العملية : مكان العملية : () يمين () يسار لاينطبق ()
 وقت الوصول للعمليات : تاريخ اجراء العملية : / /
 عند الوصول للعمليات Sing In قبل شق الجلد Time Out قبل مغادرة العمليات Sign Out

الدخول	الوقت المستقطع لضمان سلامة المريض	التوقييع
☐ أكد على المريض لما يلي ☐ هوية ☐ موضع الجراحة ☐ يمين ☐ يسار ☐ لاينطبق ☐ اسم العملية ☐ موافقة المريض	☐ يتم تقييم المريض بواسطة الجراح والتخدير قبل بدء العملية مباشرة ☐ يتأكد فريق العمل من الاتي ☐ اسم المريض ☐ الاجراء الجراحي ☐ موضع الاجراء ☐ اسم الجراح	الجراح : طبيب التخدير : الممرضة المناولة : ممرضة الافاقه : وقت الخروج من العمليات :
☐ تم تقييم المريض بواسطة الجراح ☐ نعم ☐ لا ☐ تم تحديد موضع العملية بعلامة مميزة ☐ نعم ☐ لا ☐ لاينطبق	☐ تم اعطاء المريض المضادات الحيوية الوقائية (خلال الساعة السابقة لشق الجلد) ☐ نعم ☐ لا	الجراح : طبيب التخدير : الممرضة المناولة : الوقت :
☐ نموذج ما قبل التخدير كامل ☐ نعم ☐ لا ☐ متطلبات خاصة ☐ توافر جميع التجهيزات والمعدات الخاصة بالجراحة ☐ التأكد من توافر نمسج الزرع ☐ ينطبق ☐ لاينطبق	☐ التأكد من وجود : ☐ حساسية ☐ نعم ☐ لا ☐ تم حجز الدم ☐ نعم وتم توفير جميع الاجهزة لذلك ☐ لا	ممرضة القسم : ممرضة العمليات : الوقت :

MR.OP1-1



أسم المريض :

الهيئة العامة للتأمين الصحي

رقم الملف الطبي للمريض:

فرع:

القسم المعالج :

المستشفى:

Internal Referral Form

I-Identification	Diagnosis:
S-Situation	Change in Status: Abnormal Results: Change in Treatment Plan: Others:
B-Background	Brief History: Consultation: Others:
A-Assessment	Key Changes Since Last Assessment: Conclusion About Current Situation: Others:
R-Recommendation	Labs. / Procedure / Radiology : Consult: Others:
Name of Referring Physician: Signature:	
Name of Receiving Physician: Signature:	
Date : / / Time:	

Mr.Dis.sh.1-1